

IPT-BN *przez relacje*

Adaptacja IPT Klermana dla bulimii. *NIE* fokus na jedzeniu — fokus na relacjach. 4 obszary: żałoba, spory, tranzycje ról, deficyty interpersonalne. Agras 2000 RCT: wolniejsza niż CBT, ale wyniki 12 mies. zrównane.

CZAS: 40 min · 15–20 sesji Alternatywa CBT-E lub rozszerzenie

ŹRÓDŁO: Fairburn (1991, 1993); Agras i in. (2000)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **założenia IPT-BN** (sekcja 1), zobacz **cztery obszary** pracy interpersonalnej (sekcja 2). Sekcja 3 — który obszar dotyczy Ciebie. Sekcja 4 — kiedy IPT zamiast CBT-E.

DLACZEGO TO DZIAŁA

IPT-BN (*Interpersonal Psychotherapy for Bulimia Nervosa*) — adaptacja IPT Klermana & Weissmana, opracowana przez Fairburna (1991, 1993). Założenie: bulimia jest podtrzymywana przez **problemy interpersonalne** — konflikty, izolację, przejścia życiowe. IPT **nie skupia się bezpośrednio na jedzeniu** — fokus na **jakości relacji**. Gdy relacje się poprawiają, objawy maleją bez pracy bezpośrednio nad nimi. Cztery obszary: nieprzepracowana żałoba, konflikty ról, przejścia ról, deficyty interpersonalne. Agras i in. (2000) *Archives of General Psychiatry* RCT: IPT-BN po 20 sesjach **44%** remisja, CBT **61%** — CBT szybciej. **Ale** w obserwacji 12-mies. wyniki **zrównują się** (45% vs 40%). IPT-BN jest **alternatywą** dla pacjentów odrzucających fokus jedzeniowy lub z wyraźnie interpersonalną etiologią.

01

● Założenia IPT-BN

CBT-E — FOKUS JEDZENIE

- Bezpośrednia praca z jedzeniem
- Dziennik, 3+2, ekspozycja
- Reguły żywieniowe
- Body checking, mirror exposure
- Szybsze efekty (8–12 tyg.)

IPT-BN — FOKUS RELACJE

- Praca z jakością relacji
- Konflikty, izolacja, przejścia
- *Brak* bezpośredniej pracy z jedzeniem
- 4 obszary interpersonalne
- Wolniejsze efekty, równe w 12 mies.

Mechanizm IPT-BN: poprawa jakości relacji → *redukcja vulnerability emocjonalnej* → spadek emocjonalnych wyzwalaczy epizodów → redukcja objawów bulimii. To *pośrednia* droga, ale empirycznie skuteczna. Agras i in. (2000): w obserwacji 12-mies. *żadna z dwóch terapii* nie była istotnie lepsza od drugiej. To pokazuje, że *różne ścieżki* prowadzą do tego samego celu.

02

= Cztery obszary pracy IPT

1 · NIEPRZEPRACOWANA ŻAŁOBA

Strata bliskiej osoby, rozstanie, utrata zdrowia. Bulimia jako *strategia radzenia sobie* z niedokończoną żałobą.

2 · SPORY INTERPERSONALNE

Konflikty z partnerem, rodziną, w pracy. Chroniczny stres relacyjny → napięcie emocjonalne → epizody jako ucieczka.

3 · TRANZYCJE RÓL

Macierzyństwo, ślub, przeprowadzka, studia, awans, emerytura. Zmiana życiowa rozregulowuje rutynę → wrażliwość na nawrót.

4 · DEFICYTY INTERPERSONALNE

Chroniczna izolacja, brak bliskich relacji, trudność z tworzeniem więzi. Najtrudniejszy obszar — wymaga długiej pracy.

03 ‣ Który obszar dotyczy mnie

W IPT pierwsza sesja diagnostyczna identyfikuje **jeden główny obszar** pracy. Spróbuj rozpoznać, który z czterech obszarów jest dla Ciebie najsilniejszy. Może być więcej niż jeden, ale wybiera się *jeden centralny*.

MÓJ GŁÓWNY OBSZAR INTERPERSONALNY

— który z czterech, konkretne osoby/sytuacje, jak długo trwa

JAK TEN OBSZAR WIĄŻE SIĘ Z MOJĄ BULIMIĄ

— kiedy są epizody w kontekście tych relacji, czego unikam, co tłumię

04 Kiedy IPT zamiast CBT-E

IPT JAKO PIERWSZY WYBÓR

Wyraźnie interpersonalna etiologia: świeża strata, konflikt relacyjny, przejście życiowe, długotrwała izolacja. Słabe efekty CBT-E w przeszłości.

IPT JAKO ROZSZERZENIE

PO CBT-E Z CZĘŚCIOWYM EFEKTEM — OBJAWY ZREDUKOWANE, ALE KONFLIKTY RELACYJNE POZOSTAJĄ I ZAGRAŻAJĄ NAWROTEM.

ODRZUCENIE FOKUSU JEDZENIOWEGO

Pacjent psychologicznie nie znosi fokusu na jedzeniu (dziennik, ekspozycja). IPT pozwala obejść tę barierę.

CBT-E JAKO PIERWSZY WYBÓR

Większość pacjentów z BN — CBT-E daje szybsze efekty (8-12 tyg.) i jest standardem międzynarodowych wytycznych (NICE, APA).

Klucz: IPT-BN jest *uznaną, empirycznie potwierdzoną* alternatywą dla CBT-E w leczeniu bulimii. Agras i in. (2000) *Archives of General Psychiatry* — pierwszy duży RCT porównujący IPT i CBT w bulimii.

Wynik kluczowy: CBT działa *szybciej*, IPT *wolniej*, ale w **obserwacji 12-miesięcznej** wyniki *zrównują się* (45% vs 40% remisja). Fairburn (1991, 1993) opracował IPT-BN na podstawie standardowej IPT Klermana & Weissmana — adaptacja zmienia obszary pracy, ale zachowuje *strukturę*: 15-20 sesji w 3 fazach (diagnostyczna, środkowa, końcowa). Mechanizm: *poprawa relacji* → spadek vulnerability emocjonalnej → spadek epizodów. To *pośrednia* droga — ale dla niektórych pacjentów jest *jedyną dostępną*. **NICE 2017** (brytyjskie wytyczne): CBT-E jest pierwszym wyborem dla bulimii, IPT jako drugi wybór, gdy CBT-E nieskuteczna lub odrzucona. **APA 2023** (amerykańskie): podobnie. W Polsce dostępność IPT-BN jest *ograniczona* — niewielu terapeutów posiada szkolenie. Większość polskich pacjentów otrzymuje CBT-E. Jednak *znajomość* IPT-BN jest wartościowa — pozwala kierować pacjentów do odpowiednich specjalistów, gdy CBT-E nie odpowiada profilowi.